

OZEMPIC · MOUNJARO · WEGOVY E SIMILARES — EDIÇÃO 2026

Sistema Primeiras Semanas™

O acompanhamento completo para quem está começando a caneta de emagrecimento.

*"Você não precisa estudar Ozempic.
Você precisa saber o que fazer amanhã de manhã."*

GUIA PRÁTICO POR FASE · MÓDULOS 1 A 6 · PAINEL DE CONSULTA RÁPIDA

Comece aqui

Como usar este sistema

Você não precisa ler tudo de uma vez. Este material foi organizado exatamente na ordem em que você vai **viver** o tratamento — não na ordem em que um livro explicaria a ciência.

Vá direto ao ponto que você precisa agora

- Está no dia 1? Vá para o **Módulo 1**.
- Está enjoada e sem saber se é normal? Vá para o **Módulo 2**.
- Já passou a primeira semana e quer montar sua rotina? Vá para o **Módulo 3** e o **Módulo 5**.
- Só quer checar uma tabela rápido? Vá direto para o **Painel de Consulta Rápida**, no final.

Não pule esta página

Este sistema não substitui seu médico. Ele existe para você chegar mais segura e mais organizada em cada consulta — não para substituí-la.

UM DETALHE IMPORTANTE

Imprima esse conteúdo para ter sempre ele em mãos.

Módulo 1 Estado inicial — entendendo o mecanismo e a escolha do seu remédio

Módulo 2 Primeiros dias — o que é normal sentir semana a semana

Módulo 3 Primeiras semanas — como comer sem perder músculo

Módulo 4 Primeiro mês e além — protegendo cabelo e músculos

Módulo 5 Confiança — rotina semanal, lista de compras e receitas

Módulo 6 Autonomia — custos, prescrição e economia com segurança

Painel Consulta rápida — tabela de proteínas e sinais de alerta

Entendendo o que está começando

OBJETIVO EMOCIONAL

Acalmar o medo do desconhecido

OBJETIVO PRÁTICO

Entender o mecanismo do remédio e por que o seu foi escolhido

ANTES

"Será que isso é seguro? Será que é forte demais? O que vai acontecer comigo?"

DEPOIS

"Entendi o que está acontecendo no meu corpo, e isso não é nenhum mistério."

01. Entenda o que vai acontecer com seu corpo agora

(antes: "O que é GLP-1 e como funciona no seu corpo")

Antes de tomar a próxima dose, vale entender uma coisa simples: você não está colocando no corpo uma substância estranha. GLP-1 é um hormônio que o seu próprio intestino já produz toda vez que você come. O medicamento apenas imita esse hormônio — só que numa versão que dura muito mais tempo (o seu natural dura 2 minutos; o do Ozempic e Mounjaro dura 7 dias).

Se eu pudesse voltar ao primeiro dia

Eu diria a mim mesma que a fome mais devagar e o enjoo leve das primeiras doses não são o remédio "me fazendo passar mal" — é o corpo se adaptando a um novo nível de saciedade. Isso passa, quase sempre, entre 2 e 4 semanas.

O que você vai notar nas primeiras semanas:

- A fome demora mais para chegar e passa mais rápido
- As porções que você comia antes vão parecer grandes demais
- Você vai esquecer de comer com mais frequência
- Enjoo leve, principalmente logo após as doses

Importante saber

O GLP-1 não queima gordura diretamente. Ele reduz o quanto você come. O emagrecimento vem da redução calórica que isso causa — por isso o Módulo 3 (alimentação) é o mais importante deste sistema.

Nenhuma ação além de continuar lendo. Este capítulo é só para você entender o "porquê" — o "como fazer" vem nos próximos módulos.

02. Ozempic, Mounjaro ou Wegovy: por que o seu médico escolheu esse

(antes: "Ozempic, Mounjaro ou Wegovy? As diferenças que importam")

Medicamento	Princípio Ativo	Mecanismo	Para que foi criado
Ozempic	Semaglutida	GLP-1	Diabetes tipo 2
Wegovy	Semaglutida	GLP-1	Obesidade
Mounjaro	Tirzepatida	GLP-1 + GIP	Diabetes tipo 2
Zepbound	Tirzepatida	GLP-1 + GIP	Obesidade
Victoza	Liraglutida	GLP-1	Diabetes tipo 2

Estudos mostram que a tirzepatida (Mounjaro/Zepbound) tende a produzir maior perda de peso do que a semaglutida (Ozempic/Wegovy) — em média 20% do peso corporal contra 15%. Isso **não** significa que um é "melhor" para você. O melhor medicamento é o que o seu médico prescreveu considerando o seu histórico, seus exames e suas condições de saúde.

Erro que quase todo mundo comete

Comparar a própria dose ou remédio com o de uma amiga ou de um vídeo da internet e achar que "está fazendo errado" por não ser igual. Cada prescrição é individual. Não mude o medicamento ou a dose por conta própria.

Para quem é indicado: IMC acima de 30 (obesidade) ou acima de 27 com comorbidades (diabetes, hipertensão, apneia do sono) · diabetes tipo 2 com difícil controle · pessoas que já tentaram dieta e exercício com resultado insatisfatório.

Contraindicações importantes: histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular da tireoide · síndrome de neoplasia endócrina múltipla tipo 2 · pancreatite crônica · gravidez ou amamentação · doença renal grave em estágio avançado · alergia conhecida ao princípio ativo. Esta lista não é completa — por isso a avaliação médica não é burocracia, é proteção real.

Leia isso antes da próxima aplicação

Se você está com peso normal e busca perder só 5 ou 10 kg, converse abertamente com seu médico sobre os riscos — nessa faixa de peso, o risco de perda de massa muscular é maior e o benefício, menor.

O que é normal sentir

OBJETIVO EMOCIONAL

Validar o que ela está sentindo agora

OBJETIVO PRÁTICO

Saber o que é normal semana a semana no primeiro mês

ANTES

"Isso que estou sentindo é normal ou eu deveria me preocupar?"

DEPOIS

"Eu sei exatamente em que fase estou e o que esperar da próxima."

03. Os primeiros 14 dias: o que é normal sentir (e o que não é)

(antes: "O que esperar nos primeiros 3 meses")

Semana 1 e 2 — Adaptação. O corpo está aprendendo a lidar com o novo nível de GLP-1. É comum sentir enjoo (principalmente após as refeições), saciedade rápida, cansaço leve e queda significativa do apetite. A perda de peso neste período costuma ser de 1 a 3 kg — menos do que a maioria espera, e isso é normal. O remédio está construindo base, não entregando resultado instantâneo.

Mês 2 — Estabilização. O enjoo geralmente diminui. O apetite continua reduzido. É comum o resultado "acelerar" neste mês, porque os hábitos alimentares já começaram a mudar de forma mais consistente. Perda acumulada típica: 3 a 6 kg.

Mês 3 — Ritmo de cruzeiro. A perda de peso fica mais previsível. É o momento em que a alimentação certa faz mais diferença: quem comeu proteína suficiente está perdendo gordura; quem não comeu, está perdendo músculo também (veja o Módulo 3).

O QUE FAZER HOJE

Se você está na semana 1 ou 2, isso é tudo que você precisa saber por enquanto. Guarde uma coisa: **o platô vai acontecer.** Em algum momento entre o 3º e o 6º mês, a balança vai parar de mexer por uma ou duas semanas. Isso não significa que o remédio parou de funcionar — é o corpo se adaptando. Continue o protocolo.

Quando ligar para o médico

Enjoo intenso que impede de comer ou beber água, constipação severa, dor abdominal forte, ou qualquer sintoma que pareça "demais" para você. Não existe "aguentar calada" — o médico pode ajustar a dose ou indicar suporte.

Como comer sem perder músculo

OBJETIVO EMOCIONAL

Tirar o peso da decisão "o que eu como agora"

OBJETIVO PRÁTICO

Montar pratos com proteína suficiente mesmo sem fome

ANTES

"Não sinto fome, então nem sei o que ou quando comer."

DEPOIS

"Eu sei exatamente o que colocar no prato, mesmo sem vontade de comer."

04. Como comer sem perder músculo

(antes: "Alimentação: o que comer desde o primeiro dia")

Este é o módulo mais importante do sistema. A caneta reduz a fome — mas o que você coloca no prato decide se você vai perder gordura ou músculo, se vai ter energia ou ficar prostrada.

O erro mais comum

Quando a fome desaparece, a maioria das pessoas simplesmente para de comer — café da manhã e talvez um lanche, e pronto. A balança despenca rápido, mas o preço é alto: perda de massa muscular, queda de cabelo, fraqueza, queda de imunidade e efeito rebote quando o tratamento termina.

A regra de ouro: proteína primeiro. Mesmo sem fome, a meta mínima é 1,2g de proteína por quilo de peso corporal, por dia. Para 80kg, isso é pelo menos 96g diários, distribuídos em 3 refeições.

Exemplo prático (80kg): café — 2 ovos + 1 iogurte grego (≈28g) · almoço — 120g de frango ou peixe (≈30g) · jantar — 100g de carne magra ou atum (≈25g) · **total: 83g**, próximo da meta.

O que priorizar:

- Proteínas magras: frango, peixe, ovos, atum, iogurte grego, queijo cottage
- Vegetais não amiláceos: brócolis, espinafre, alface, pepino, tomate, abobrinha
- Gorduras boas em porções pequenas: azeite, abacate, castanhas
- Fibras solúveis: aveia, chia, linhaça

O que evitar ou reduzir bastante:

- Ultraprocessados (não ativam a saciedade direito)
- Bebidas alcoólicas (risco de hipoglicemia, piora o enjoo)

- Frituras e alimentos muito gordurosos (aumentam o enjoo)
- Refrigerantes e sucos artificiais (calorias líquidas que não saciam)

O QUE FAZER HOJE

Escolha uma fonte de proteína para cada uma das suas próximas 3 refeições, mesmo que a porção seja pequena. É a única ação deste módulo que realmente importa.

(Tabela completa de proteína por porção disponível no Painel de Consulta Rápida)

05. Os 7 erros que travam o resultado

Depois de acompanhar centenas de relatos de pessoas em tratamento, estes são os erros mais comuns e mais caros:

1. **Não comer proteína suficiente** — a receita certa para perder músculo e travar o metabolismo.
2. **Pular refeições completamente** — leva a picos de enjoo, tontura e fraqueza. Prefira refeições pequenas e frequentes.
3. **Não se hidratar** — o remédio reduz a sede em muita gente. Meta: pelo menos 2 litros de água por dia.
4. **Parar de se exercitar** — o exercício de força é o principal protetor de massa muscular durante o emagrecimento.
5. **Aumentar a dose antes do tempo** — doses maiores aumentam efeitos colaterais sem necessariamente dobrar o resultado.
6. **Tratar o remédio como solução definitiva** — é uma ferramenta, não uma cura. Quem não muda hábitos tem mais chance de recuperar peso ao parar.
7. **Não avisar o médico sobre efeitos colaterais** — enjoo intenso ou constipação severa não são "coisas para aguentar calada". O médico pode ajustar.

Não pule esta página

Releia esta lista na virada de cada mês de tratamento. É o checklist mais rápido para saber se você está no caminho certo.

Protegendo cabelo e músculos

OBJETIVO EMOCIONAL

Tirar o medo de "vou ficar flácida / vou ficar careca"

OBJETIVO PRÁTICO

Proteger massa muscular e cabelo com estratégia concreta

ANTES

"Todo mundo fala que vai cair o cabelo e perder a firmeza."

DEPOIS

"Sei exatamente o que fazer para isso não acontecer comigo."

06. Protegendo seu cabelo e seus músculos

(antes: "Como proteger seus músculos e seu cabelo")

Queda de cabelo e perda de massa muscular são as duas queixas mais frequentes de quem usa GLP-1 sem orientação. As duas são evitáveis.

Por que o cabelo cai: não é o medicamento em si — é a restrição calórica severa. Quando o corpo recebe muito menos energia do que precisa, ele prioriza órgãos vitais e pausa o ciclo capilar. O cabelo que cai agora estava em desenvolvimento há 3 meses.

Como minimizar:

- Manter ingestão adequada de proteína (queratina é proteína)
- Suplementar biotina se o médico indicar
- Garantir ferro adequado — a deficiência potencializa a queda
- Não cortar calorias de forma agressiva
- A queda costuma cessar entre o 3º e o 6º mês de tratamento

Por que o músculo vai embora: quando você come muito pouco, o corpo busca energia de algum lugar. Se não vier da gordura rápido o suficiente, ele quebra proteína muscular como combustível. Resultado: você emagrece na balança, mas perde firmeza e fica mais fraca.

Protocolo de proteção muscular:

- Proteína: 1,2 a 1,6g por kg de peso corporal por dia, sem exceção
- Exercício de força: pelo menos 2 a 3x por semana, mesmo que leve
- Não corte calorias abaixo de 1.200 kcal/dia sem supervisão médica
- Distribua a proteína em pelo menos 3 refeições
- Creatina pode ser aliada — converse com seu médico

Leia isso antes da próxima aplicação

Proteção de músculo e cabelo não é sobre um suplemento mágico. É sobre proteína suficiente, todos os dias, desde a primeira semana.

Rotina pronta para seguir

OBJETIVO EMOCIONAL

Sentir que não precisa mais decidir nada sozinha

OBJETIVO PRÁTICO

Ter uma rotina pronta e lista de compras para seguir sem pensar

ANTES

"Não tenho energia para planejar o que comer todo dia."

DEPOIS

"Já está tudo montado, só preciso seguir."

07. O plano simples para sobreviver às primeiras semanas

(antes: "Rotina semanal pronta para seguir")

Chega de teoria. Aqui está uma rotina completa para os 7 dias da semana, pensada para quem tem pouco apetite mas precisa nutrir o corpo de verdade.

Princípios: proteína em todas as refeições, sem exceção · porções pequenas, 3 a 4x ao dia · sem necessidade de contar calorias, só seguir o modelo · adaptável — substitua por equivalentes da tabela de proteína.

Dia	Café	Almoço	Lanche	Jantar
Seg	2 ovos mexidos + pão integral	Frango grelhado (120g) + salada + arroz	iogurte grego natural	Omelete de 2 ovos com queijo + legumes
Ter	Vitamina de banana com proteína + tosta	Peixe assado (150g) + brócolis + batata-doce	Castanhas + fruta	Sopa de legumes com frango desfiado
Qua	iogurte grego com granola sem açúcar	Carne magra (120g) + salada + lentilha	Cottage com cenoura baby	Atum + tomate + ovos cozidos
Qui	Tapioca com cottage + ovo mexido	Frango (130g) + quinoa + legumes assados	Maçã + pasta de amendoim	Omelete de 3 claras + gema com espinafre
Sex	2 ovos + queijo branco + fruta	Salmão (120g) + salada + purê de abobrinha	iogurte proteico	Sopa de feijão branco com legumes e frango
Sáb	Panqueca de aveia com ovos	Refeição livre com porção controlada	Castanhas + fruta	Omelete ou ovos
Dom	Opcional			

Café caprichado — ovos, queijo,
frios magros, fruta

Refeição social, porção
menor

Leve — sopa ou salada
proteica

Hidratação

Pelo menos 2 litros de água por dia. Água com gás ajuda a reduzir o enjoo. Chá de gengibre também é aliado.

O QUE FAZER HOJE

Imprima ou salve esta tabela no celular. Use-a como padrão nas próximas duas semanas — depois, adapte com a sua própria variação.

Lista de compras da semana

PROTEÍNAS

Peito de frango (600g) · carne magra (400g) · ovos (1 cartela) · atum em lata (3-4un) · salmão ou tilápia (300g) · iogurte grego natural (4 potes) · queijo cottage · queijo branco ou ricota (200g)

CARBOIDRATOS DE QUALIDADE

Batata-doce (500g) · arroz integral (500g) · aveia em flocos (400g) · pão integral · quinoa (250g) · lentilha seca (250g)

VEGETAIS

Brócolis · abobrinha (2un) · cenoura (500g) · tomate (500g) · alface ou mix de folhas · espinafre · pepino (2un)

FRUTAS & OUTROS

Banana · maçã (4un) · fruta de preferência para lanches · azeite extra virgem · castanhas variadas (200g) · chia ou linhaça (200g) · proteína em pó (opcional) · chá de gengibre

10 receitas para quem come pouco

1 Omelete proteico de 3 ingredientes — 2 ovos + 1 col. de cottage + queijo ralado, fritos sem óleo. ~22g proteína · 5 min

2 Bowl de atum com abacate — 1 lata de atum + ¼ abacate amassado + tomate + limão e azeite. ~28g · 5 min

3 Iogurte grego com chia e fruta — 1 pote de iogurte + 1 col. de chia + fruta picada. ~18g · 2 min + espera

4 Frango desfiado com brócolis — 120g de frango + brócolis no vapor + azeite, sal e alho. ~34g · 15 min

5 Sopa de legumes com frango — frango desfiado + caldo natural + cenoura, abobrinha, espinafre. ~25g · 20 min · ideal para dias de mais enjoo

6 Panqueca de aveia e ovo — 2 ovos + 3 col. de aveia + 1 banana madura, fritos. ~18g · 10 min

7 Cottage com cenoura e ervas — 100g de cottage + cenoura baby + tempero verde. ~12g · 2 min · bom lanche noturno

8 Wrap de alface com atum — folhas de alface + atum + tomate + pepino + azeite. ~22g · 5 min

9 Salmão com legumes assados — 100g de salmão + abobrinha + tomate na air fryer/forno. ~26g · 20 min

10 Vitamina proteica — 200ml de leite/bebida vegetal + 1 scoop de whey + banana + chia, batidos. ~28g · 3 min · para quem não consegue comer sólido de manhã

Custo, prescrição e economia

OBJETIVO EMOCIONAL

Sentir que o tratamento cabe na vida real dela, inclusive no bolso

OBJETIVO PRÁTICO

Saber como conseguir a receita e reduzir custo com segurança

ANTES

"Isso cabe no meu orçamento? Onde eu consigo a receita sem gastar uma fortuna?"

DEPOIS

"Sei exatamente meus caminhos, e sei como economizar sem correr risco."

08. Quanto custa e como pagar menos

(antes: "Quanto custa e onde encontrar mais barato")

Medicamento	Dose	Preço médio
Ozempic 0,25mg/0,5mg	Inicial	R\$ 900 – R\$ 1.100/mês
Ozempic 1mg	Manutenção	R\$ 1.100 – R\$ 1.400/mês
Mounjaro 2,5mg	Inicial	R\$ 700 – R\$ 950/mês
Mounjaro 5mg+	Manutenção	R\$ 950 – R\$ 1.300/mês
Wegovy	Variável	R\$ 1.200 – R\$ 1.600/mês

Como reduzir o custo com segurança:

- Compare preços entre farmácias — a variação chega a 30% para o mesmo produto
- Programas de desconto dos fabricantes (Novo Nordisk e Eli Lilly oferecem programas de paciente)
- Farmácias de manipulação podem oferecer semaglutida manipulada por preço menor — pergunte ao médico se é opção adequada para você
- Plataformas de comparação de preço ajudam a achar o menor valor na sua região

Nunca compre sem receita ou de fontes não confiáveis

Medicamentos falsos ou mal armazenados são um problema real. Compre sempre em farmácia registrada na Anvisa, com nota fiscal.

09. Como conseguir a prescrição

(antes: "Como conseguir a prescrição médica")

No Brasil, os medicamentos GLP-1 são vendidos apenas com prescrição médica. Existem caminhos acessíveis:

- **SUS:** oferece semaglutida para pacientes com diabetes tipo 2 dentro de critérios específicos.
Caminho: UBS do bairro → clínico geral → exames → encaminhamento ao endocrinologista.
Demora, mas é gratuito.
- **Plano de saúde:** comece pelo clínico geral ou endocrinologista credenciado. Com diagnóstico de obesidade (CID E66) ou diabetes (CID E11), muitos planos cobrem consulta e parte dos exames — o medicamento em si raramente é coberto.
- **Consulta particular:** endocrinologistas e clínicos com foco em emagrecimento são os especialistas indicados. Plataformas de telemedicina reduziram bastante o custo de consultas.

Dica prática

Leve seus exames recentes para a consulta, se tiver — glicemia em jejum, hemoglobina glicada, TSH, colesterol e triglicerídeos ajudam o médico a decidir mais rápido e com mais segurança.

Consulte sempre que precisar

Sem reler o sistema inteiro

Tabela de proteína por porção

Alimento	Porção	Proteína
Peito de frango grelhado	100g	31g
Carne bovina magra	100g	26g
Atum em lata (água)	1 lata (170g)	34g
Salmão grelhado	100g	25g
Ovo inteiro	1 unidade	6g
Clara de ovo	1 unidade	4g
iogurte grego natural	1 pote (170g)	17g
Queijo cottage	100g	11g
Queijo branco	1 fatia (30g)	6g
Ricota	100g	12g
Lentilha cozida	100g	9g
Feijão cozido	100g	8g
Atum fresco	100g	30g
Proteína em pó (whey)	1 scoop (30g)	22-25g
Amendoim	30g	8g

Sinais de alerta — quando ligar para o médico

- Enjoo intenso que impede de comer ou beber água
- Constipação severa ou dor abdominal forte
- Qualquer sintoma que pareça "demais" comparado ao que este sistema descreve como normal
- Dúvida sobre aumentar dose, trocar medicamento ou interromper o tratamento

LEMBRETE

Imprima esse conteúdo para ter sempre ele em mãos.

Você está no lugar certo.

Começar um tratamento com GLP-1 é uma decisão importante. Agora você tem, organizado por fase, o que a maioria das pessoas só descobre no meio do caminho — depois de já ter cometido os erros.

Volte a este sistema sempre que tiver dúvida. E lembre-se: **o medicamento é a ferramenta — você é o resultado.**

Disclaimer médico: Este material tem caráter exclusivamente educativo e informativo. Não substitui consulta, diagnóstico ou tratamento médico ou nutricional. Todas as decisões sobre medicamentos, doses e alimentação devem ser tomadas em conjunto com profissionais de saúde habilitados. Os valores de preço apresentados são estimativas baseadas em dados públicos de 2026 e podem variar.